

ALUNO: 231-000792 JOYCE RAMOS DE SOUZA LIMA

Prova: 00 | 3a Etapa | Biomedicina 7P

Status: APROVADO

NOTA FINAL

95.5 / 100.0

APROVADO

DETALHAMENTO POR QUESTAO

Q	Tema	Resultado	Nota
Q1	V/F - Esporotricose	7/10 corretos	10.5/15.0
Q2	V/F - Paracoccidioidomicose	10/10 corretos	15.0/15.0
Q3	V/F - Criptococose	10/10 corretos	15.0/15.0
Q4	MCQ - Classificacao das Micoses	Resp: C Gab: C	6.0/6.0
Q5	MCQ - Dermatofitos	Resp: B Gab: D	6.0/6.0
Q6	MCQ - Histoplasmosse	Resp: B Gab: B	6.0/6.0
Q7	V/F - Candida spp	10/10 corretos	15.0/15.0
Q8	MCQ - Aspergilose	Resp: B Gab: B	6.0/6.0
Q9	MCQ - Dimorfismo Fungico	Resp: D Gab: D	6.0/6.0
Q10	MCQ - Diagnostico Laboratorial	Resp: A Gab: A	6.0/6.0
Q11	MCQ - Triagem Clinica	Resp: C Gab: C	4.0/4.0
TOTAL			95.5/100.0

Biomedicina – 7º Período | Micologia Clínica | Prof. Bruno de Andrade Pires | 1º Semestre / 2026

NOME DO(A) ALUNO(A)

MATRÍCULA

TURMA

DATA

TABELA DE PONTUAÇÃO – TOTAL: 100 PONTOS

Q	Tipo	Tema / Conteúdo	Valor	Nota
1	Verdadeiro/Falso	Esporotricose — Caso Clínico (epidemia zoonótica)	15,0	
2	Verdadeiro/Falso	Paracoccidiodomicose — Micose Sistêmica Endêmica	15,0	
3	Verdadeiro/Falso	Criptococose — Meningoencefalite no HIV/AIDS	15,0	
7	Verdadeiro/Falso	Candida spp. — Da Comensal à Ameaça Hospitalar	15,0	
Subtotal V/F — 4 × 15,0			60,0	
4	Múltipla Escolha	Classificação das Micoses (Superficial → Oportunista)	6,0	
5	Múltipla Escolha	Dermatófitos — Conceitos Básicos	6,0	
6	Múltipla Escolha	Histoplasmose — Epidemiologia (Cavernas, Morcegos)	6,0	
8	Múltipla Escolha	Aspergilose Invasiva — Diagnóstico (Galactomanana)	6,0	
9	Múltipla Escolha	Dimorfismo Fúngico — Conceito e Diagnóstico	6,0	
10	Múltipla Escolha	Diagnóstico Laboratorial (KOH + Ágar Sabouraud)	6,0	
11	Múltipla Escolha	Triagem: Doença + Fungo + Transmissão	4,0	
Subtotal MCQ — 6 × 6,0 + 4,0			40,0	
TOTAL GERAL			100,0	

Q1-1	Sporothrix = micose subcutânea	✓	F	
Q1-2	Transmissão por inalação de esporos			
Q1-3	Gato doméstico = vetor principal	✓	F	
Q1-4	Forma clássica e zoonótica = mesmo mecanismo			
Q1-5	Dimorfismo: bolor 25°C / levedura 35-37°C	✓	F	
Q1-6	Cultura cresce exclusivamente a 37°C	✓		
Q1-7	Amostra: pus/biopsia: KOH, Gram, Sabouraud	✓		
Q1-8	Tratamento 1ª escolha = anfotericina B IV	✓	F	
Q1-9	Itraconazol oral 3-6 meses + SUS gratuito	✓	F	
Q1-10	Orientação correta = abandonar o gato		F	
Q2-1	Fungo muda de forma (solo x corpo)	✓	F	
Q2-2	Transmitida por mordedura/arranhadura do tatu	✓	F	
Q2-3	Respirar poeira do solo (trabalho rural)	✓		
Q2-4	Forma crônica (lenta) = mais comum em adultos	✓		
Q2-5	Homens 30-60 anos rurais = 90% dos casos	✓		
Q2-6	Diagnóstico apenas por exame de sangue	✓	F	
Q2-7	Microscopia de escarro/lesão bucal ajuda	✓	F	
Q2-8	Único tratamento = cirúrgico		F	
Q2-9	Antifúngico oral fornecido pelo SUS	✓	F	
Q2-10	Doença restrita à região Norte do Brasil		F	
Q3-1	Cryptococcus tem cápsula-escuro	✓	F	
Q3-2	Contato direto com pombo transmite		F	
Q3-3	Inalação de partículas do fungo	✓		
Q3-4	Doença oportunista (imunodeprimidos)	✓		
Q3-5	Só pega quem tem HIV		F	
Q3-6	Tinta da China mostra cápsula (halo claro)	✓	F	
Q3-7	Diagnóstico só pela tinta da China	✓	F	
Q3-8	Tratamento em 3 fases pelo SUS	✓	F	
Q3-9	Tratamento inicial = fluconazol sozinho		F	
Q3-10	Todo HIV+ deve tomar fluconazol preventivo	✓	F	
Q4-1	C. albicans vive em pessoas saudáveis	✓		
Q4-2	C. albicans muda de forma arredondada → alongada	✓		
Q4-3	Candidase vaginal = comum com ATB/gravidez/DM	✓		
Q4-4	C. albicans multirresistente sobrevive em superfícies	✓		
Q4-5	Transmissão hospitalar: por contato, não pelo ar	✓		
Q4-6	C. albicans se pega pelo ar (como gripe)		F	
Q4-7	C. albicans é facilmente tratada com fluconazol	✓	F	
Q4-8	C. albicans descoberta no Brasil (Salvador) 2020		F	
Q4-9	Prevenção: priv. pel. lavar mãos todos os internados		F	
Q4-10	C. albicans perigosa por esporos no ar		F	

Q4	Q5	Q6	Q8	Q9	Q10	Q11
A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E	E

UNIPAC – FUPAC Ulsá / MG | Biomedicina – 7º Período | Micologia Clínica | 3ª Etapa | Prof. Bruno de Andrade Pires | 1º Semestre / 2026

UNIPAC – FUPAC UBÁ / MG | BIOMEDICINA 7^ºP | MICOLOGIA CLÍNICA

Caderno de Questões — 3ª Etapa

Prof. Bruno de Andrade Pires | Duração: 2h | Valor: 100 pts | Este caderno fica com o(a) aluno(a)

PARTE II — MÚLTIPLA ESCOLHA (Q4-Q6, Q8-Q11)

Para cada questão, assinale **apenas uma** alternativa (A-E) na Folha de Respostas.

Questão 6 — Histoplasmose (6,0 pts)

A histoplasmose é a micose endêmica mais comum nas Américas (>40 milhões infectados, maioria assintomática). *Histoplasma capsulatum* é dimórfico, vive em solos enriquecidos com excretas de aves e morcegos (cavernas, galinheiros, forros). Transmissão: **inalação de microconídios** em aerossóis (limpeza, demolição, espeleologia). No Brasil, casos em todas as regiões, com destaque para áreas de cavernas.

Sobre epidemiologia e transmissão da histoplasmose, assinale a alternativa correta:

- ☐ A Principal reservatório: água de rios/lagos tropicais; infecção por ingestão.
- ☒ B *capsulatum* tem nicho em solos com excretas de morcegos/aves; infecção por inalação de microconídios em aerossóis.
- ☐ C Transmissão de pessoa a pessoa por gotículas respiratórias, explicando surtos familiares.
- ☐ D Forma disseminada afeta exclusivamente pacientes com AIDS e CD4 < 50.
- ☐ E Diagnóstico é feito exclusivamente por sorologia (imunodifusão); cultura contraindicada.

Questão 9 — Dimorfismo Fúngico (6,0 pts)

Fungos dimórficos (*Histoplasma*, *Paracoccidioides*, *Sporothrix*, *Blastomyces*, *Coccidioides*) alternam entre **bolor** (25°C, ambiente) e **levedura** (37°C, tecidos). A **temperatura** é o principal regulador. Diagnóstico: cultivar a amostra nas duas temperaturas e observar a conversão — passo essencial para distinguir patógenos verdadeiros de contaminantes ambientais. OMS (2022) lista *Histoplasma* e *Paracoccidioides* como alta prioridade.

Sobre dimorfismo fúngico e sua importância diagnóstica, assinale a alternativa correta:

- ☐ A *Candida albicans* é dimórfica no mesmo sentido que *Histoplasma*: ambos alternam bolor/levedura só em resposta à temperatura.
- ☐ B A forma de bolor (25°C) é a parasitária — hifas penetram ativamente nas células humanas.
- ☐ C A conversão bolor→levedura só ocorre no laboratório; na infecção natural o fungo mantém a forma de entrada.
- ☒ D A temperatura governa o dimorfismo: 25°C → bolor (ambiente); 37°C → levedura (corpo). Cultivar nas duas temperaturas confirma o diagnóstico de micoses por fungos dimórficos.
- ☐ E As duas formas (bolor e levedura) pertencem a espécies diferentes que convivem no solo.

Questão 11 — Triagem Clínica (4,0 pts)

Transmissão varia: **inalação** (fungos do solo, ex. *Histoplasma*, *Paracoccidioides*, *Coccidioides*), **contato com animais** (dermatofitos zoonóticos, *Sporothrix* via gatos) e **contato interpessoal** (dermatofitos antropofílicos). A anamnese (onde mora, trabalho, contato com animais, ambientes como cavernas/galinheiros) é peça-chave para a hipótese diagnóstica antes do laboratório.

Sobre a correlação doença fúngica × agente × transmissão, assinale a alternativa correta:

- ☐ A Dermatofitose (Tinea corporis): agente dermatófito (*Microsporum/Trichophyton*); contaminação por inalação de esporos do solo.
- ☐ B Histoplasmose pulmonar (após caverna com morcegos): agente *Paracoccidioides*; contaminação por inalação de conídios do solo.
- ☒ C Esporotricose linfocutânea (nódulos/úlceras no braço após arranhão de gato): agente *Sporothrix*; contaminação por contato com gatos infectados (arranhadura, mordedura, secreção).
- ☐ D Criptococose meningocelétrica em HIV+: agente *Cryptococcus*; contaminação por contato direto com pombos e suas fezes.
- ☐ E Paracoccidioidomicose (trabalhador rural, lesões bucais): agente *Aspergillus fumigatus*; contaminação por inalação durante manejo da terra.

Questão 8 — Aspergilose Invasiva (6,0 pts)

Aspergilose invasiva (>200.000 casos/ano no mundo) afeta imunocomprometidos graves (transplantados de medula, neutropenia <500). Apresenta febre persistente + nódulos pulmonares com "sinal do halo" na TC. *Aspergillus fumigatus*: prioridade crítica da OMS (2022). Diagnóstico rápido: **galactomanana** (antígeno da parede fúngica) no soro ou lavado broncoalveolar (LBA).

Homem, 58a, transplante de medula há 21 dias, neutrófilos 120/mm³, febre persistente + nódulos com sinal do halo na TC. Suspeita de aspergilose invasiva. Assinale o exame laboratorial mais indicado:

- ☐ A Exame direto do escarro com KOH — método mais confiável, *Aspergillus* sempre abundante no escarro.
- ☐ B Pesquisa de galactomanana no soro/LBA — detecta molécula da parede do fungo liberada na infecção; principal método rápido em hospitais.
- ☒ C Galactomanana é PCR que procura DNA do fungo no sangue (teste genético).
- ☐ D Cultura do escarro detecta o fungo em >90% dos casos; sozinha fecha o diagnóstico.
- ☐ E Pesquisa de IgG contra *Aspergillus* — mais indicada, pois pacientes com baixa defesa produzem muitos anticorpos.

Questão 10 — Diagnóstico Laboratorial (6,0 pts)

KOH 10-20%: dissolve queratina e restos celulares sem danificar a parede fúngica (quitina), revelando hifas/leveduras ao microscópio. Indicado para pele, unha, pelo e escarro. **Ágar Sabouraud**: meio padrão (glicose + peptona + pH ~5,6 ácido), cresce leveduras e fungos filamentosos, inibe bactérias. Barato e ainda muito utilizado no mundo.

Sobre o exame direto mais usado na rotina micológica e o meio de cultura padrão, assinale a alternativa correta:

- ☒ A KOH 10-20% dissolve queratina sem danificar a parede fúngica, permitindo visualização rápida de hifas/leveduras; Ágar Sabouraud (glicose + peptona + pH ~5,6) é o meio padrão, crescendo leveduras e fungos filamentosos.
- ☐ B KOH tinge as estruturas fúngicas de azul escuro; Ágar Sabouraud tem pH ácido que favorece o crescimento fúngico.
- ☐ C Sabouraud (glicose + peptona + pH neutro) isola bactérias e fungos; KOH é reservado para sangue e líquido.
- ☐ D KOH dissolve a parede fúngica, permitindo extração de DNA; Sabouraud é seletivo só para leveduras.
- ☐ E KOH fornece identificação definitiva da espécie (sem necessidade de cultura); Sabouraud é usado exclusivamente para dermatófitos.

Questão 1

afirmação (A) falsa porque a transmissão ocorre por aerossóis e inalação de conídios em ambientes e não por inalação de esporos.

afirmação (B) falsa porque afirma que a transmissão ocorre por contato com animais e não por inalação de esporos.

afirmação (C) falsa porque a transmissão ocorre por contato com animais e não por inalação de esporos.

afirmação (D) falsa porque a transmissão ocorre por contato com animais e não por inalação de esporos.

questão 2

alternativa (2) Zoonose é a transmissão e por insetos de animais contaminados e não plantas

alternativa (6) Zoonose é diagnóstico feito por microscopia de imunofluorescência + cultura

alternativa (8) Zoonose é tratamento e por antígenos de

alternativa (10) Zoonose abrange todo a América Latina

questão 3

alternativa (2) Zoonose é doença não se pode manifestar em pessoas de uma por insetos de partículas de zoonose.

alternativa (5) Zoonose pode ser HIV também pode causar a doença

alternativa (7) Zoonose é diagnóstico também pode ser feito por cultura e testes rápidos.

alternativa (9) Zoonose é tratamento e feito com insetos com antígenos B + imunização, manutenção com quimioprofilaxia.

alternativa (10) Zoonose é zoonose todo HIV tanto que não se pode ser

questão 4

alternativa (6) Zoonose é zoonose não se pode ser de uma para outra

alternativa (8) Zoonose é zoonose não se pode ser de uma para outra quando a transmissão é direta

alternativa (9) Zoonose é zoonose não se pode ser de uma para outra

alternativa (10) Zoonose é zoonose não se pode ser de uma para outra

FUPAC-UNIPAC

UNIPAC — UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS

FUPAC — Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ubá

Folha de Respostas — 3ª Etapa

Biomedicina — 7º Período | Micologia Clínica | Prof. Bruno de Andrade Pires | 1º Semestre / 2026

⚠ Atenção: Esta folha é o ÚNICO documento a ser devolvido. Preencha com caneta azul ou preta, sem rasuras. Para afirmações falsas, escreva a frase corrigida na coluna "Correção". Valor de cada questão indicado na tabela abaixo.

NOME DO(A) ALUNO(A)

MATRÍCULA

TURMA

DATA

TABELA DE PONTUAÇÃO — TOTAL: 100 PONTOS

Q	Tipo	Tema / Conteúdo	Valor	Nota
1	Verdadeiro/Falso	Esporotricose — Caso Clínico (epidemia zoonótica)	15,0	
2	Verdadeiro/Falso	Paracoccidioidomicose — Micose Sistêmica Endêmica	15,0	
3	Verdadeiro/Falso	Criptococose — Meningoencefalite no HIV/AIDS	15,0	
7	Verdadeiro/Falso	Candida spp. — Da Comensal à Ameaça Hospitalar	15,0	
Subtotal V/F — 4 x 15,0			60,0	
4	Múltipla Escolha	Classificação das Micoses (Superficial — Oportunista)	6,0	
5	Múltipla Escolha	Dermatófitos — Conceitos Básicos	6,0	
6	Múltipla Escolha	Histoplasmose — Epidemiologia (Cavernas, Morcegos)	6,0	
8	Múltipla Escolha	Aspergilose Invasiva — Diagnóstico (Galactomanana)	6,0	
9	Múltipla Escolha	Dimorfismo Fúngico — Conceito e Diagnóstico	6,0	
10	Múltipla Escolha	Diagnóstico Laboratorial (KOH + Ágar Sabouraud)	6,0	
11	Múltipla Escolha	Triagem: Doença + Fungo + Transmissão	4,0	
Subtotal MCQ — 6 x 6,0 + 4,0			40,0	
TOTAL GERAL			100,0	

V/F — MARQUE V OU F E CORRIJA AS FALSAS

	V	F
Q1-1 Sporothrix - micose subcutânea	✓	
Q1-2 Transmissão por inalação de esporos		F
Q1-3 Gato doméstico - vetor principal	✓	
Q1-4 Forma clássica e zoonótica = mesmo mecanismo		F
Q1-5 Dimorfismo: bolor 25°C / levedura 35-37°C	✓	
Q1-6 Cultura cresce exclusivamente a 37°C	✓	
Q1-7 Amostra: pus/biopsia; KOH, Gram; Sabouraud	✓	
Q1-8 Tratamento 1ª escolha = anfotericina B IV		F
Q1-9 Itraconazol oral 3-6 meses + SUS gratuito	✓	
Q1-10 Orientação correta = abandonar o gato		F
Q2-1 Fungo muda de forma (solo x corpo)	✓	
Q2-2 Transmissão por mordedura/arranhadura do tatu	✓	F
Q2-3 Respirar poeira do solo (trabalho rural)	✓	
Q2-4 Forma crônica (lenta) = mais comum em adultos	✓	
Q2-5 Homens 30-60 anos rurais = 80% dos casos	✓	
Q2-6 Diagnóstico apenas por exame de sangue		F
Q2-7 Microscopia de escarro/lesão bucal ajuda	✓	F
Q2-8 Único tratamento = cirúrgico		F
Q2-9 Antifúngico oral fornecido pelo SUS	✓	F
Q2-10 Doença restrita à região Norte do Brasil		F
Q3-1 Cryptococcus tem cápsula-escudo	✓	F
Q3-2 Contato direto com pombos transmite	✓	F
Q3-3 Inalação de partículas do fungo	✓	
Q3-4 Doença oportunista (imunodeprimidos)	✓	
Q3-5 Só pega quem tem HIV		F
Q3-6 Tinta da China mostra cápsula (halo claro)	✓	
Q3-7 Diagnóstico só pela tinta da China	✓	
Q3-8 Tratamento em 3 fases pelo SUS	✓	
Q3-9 Tratamento inicial = fluconazol sorzinho		F
Q3-10 Todo HIV+ deve tomar fluconazol preventivo		F
Q7-1 C. albicans vive em pessoas saudáveis	✓	
Q7-2 C. albicans muda de forma (arredondada — alongada)	✓	
Q7-3 Candidíase vaginal: comum com ATB/gravidez/DI	✓	
Q7-4 C. auris: multirresistente, sobrevive em superfícies	✓	
Q7-5 Transmissão hospitalar: por contato, não pelo ar	✓	
Q7-6 C. albicans se pega pelo ar (como gripe)		F
Q7-7 C. auris é facilmente tratada com fluconazol		F
Q7-8 C. auris descoberta no Brasil (Salvador) 2020	✓	F
Q7-9 Prevenção principal: vacinar todos os internados		F
Q7-10 C. auris perigosa por esporos no ar		F

MCQ — ASSINALE UMA ALTERNATIVA POR QUESTÃO

Q1	Q5	Q6	Q8	Q9	Q10	Q11
A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E	E

UNIPAC — FUPAC Ubá / MG | Biomedicina — 7º Período | Micologia Clínica | 3ª Etapa | Prof. Bruno de Andrade Pires | 1º Semestre / 2026

UNIPAC — FUPAC UBÁ / MG | BIOMEDICINA 7ºP | MICOLOGIA CLÍNICA

Caderno de Questões — 3ª Etapa

Prof. Bruno de Andrade Pires | Duração: 2h | Valor: 100 pts | Este caderno fica com o(a) aluno(a).